

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 16:59:23

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Patricia Carmen Mora Mora
Edad : 53a 9m 11d
Dirección : Pasaje Seis #646. Carol Urzua

Rut : 10.884.453-1
Fecha Nacto: 18/04/1972
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1121107
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5012 2402

N° Epicrisis
470472

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 26/12/2025 03:58

Días Estadía: 34

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 29/01/2026 16:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

diarrea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Patricia Carmen Mora Mora
RUT: 10884453-1
Edad: 53 años

FI HSR: 25/12/25
FI UTIM: 30/12/25
FI UCI: 04/01/26
FI UTIM: 21/01/26
FI SALA: 23/01/26

ANTECEDENTES

- Médicos: Tumor neuroendocrino de pulmón con MTT hepáticas y óseas, en tratamiento con somatostatina + everolimus.
- Quirúrgicos: colecistectomía, Tu pulmonar (oct/21).
- Fármacos: Tramadol, Paracetamol, Metoclopramida, Everolimus, Loperamida, Somatostatina
- Alergias: niega.
- Hábitos: TBQ IPA 17 \$ hace 4 años; OH (-); Drogas (-).
- Social: vive con marido y 2 hijos, trabaja como administrativo. ECOG 0 de base, autovalente.

ANAMNESIS

Paciente con antecedente de Tumor neuroendocrino de pulmón con metástasis hepáticas y óseas, en tratamiento con Somatostatina y Everolimus. Consulta en SU por cuadro de 3 días de evolución de calofríos, CEG, diarrea y vómitos > 10 episodios al día. Al interrogatorio dirigido niega disentería, sangrado, fiebre, antecedentes de viajes recientes o ingesta de alimentos sospechosos. Ingres a en regulares condiciones generales, taquicárdica (130 lpm), hipotensa (77/64 mmHg), afebril, sin requerimientos de O2 suplementario. Al examen físico se describe somnolienta, bien perfundida, abdomen con masa palpable conocida, sin edema. En estudio de laboratorio destaca ácido láctico en 67.8, PCR 150.1, creatinina 3.49 (Basal 0.68 24/11), elevación de pruebas hepáticas en patrón colestásico. En contexto de sospecha de shock hipovolémico v/s séptico se inicia reanimación con volumen, tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona/Metronidazol para cobertura de foco abdominal y se hemocultiva. Se hospitaliza para continuar estudio y manejo. En TAC AP se observa desarrollo de necrosis en MTT hepáticas conocidas, además de signos de obstrucción intestinal de bajo grado sin sufrimiento de asas.

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 16:59

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 16:59:23

Página 2 de 5

EXAMEN FÍSICO DE INGRESO

CSV: T 36.2, FC 130 lpm, PA 77/64 mmHg, SatO2 96% ambiental

RCG, GCS 15, somnolienta pero cooperadora

bien perfundida, tibia, mottling 0

RR2TSS MP + SRA, UMA (-)

Abdomen: masa abdominal indurada, conocida, sin cambios, sin dolor a la palpación, PP (-)

EElI: sin edema o empastamiento

LABORATORIO DE INGRESO

25/12: Ácido Láctico 67.8 (7.5) PCR 150.1 BiliT 0.60 BiliD 0.19 FA 588 GGT 114 GOT 74 GPT 139 Gluc 218 LDH 582 BUN 52.9 Crea 3.49 (Basal 0.68 24/11) ELP 138/3.27/94 GSV: pH 7.36 PCO2 27.0 HCO3 14.8 Ca 9.5 Hcto 42.8 Hb 15.1 VCM 73 Leucos 7700 Neutros 85.4 RAN 6600 Plaq 560.000 INR 1.27 TTPA 36.5

MICROBIOLOGÍA

25/12: HC 1 y 2 (-), UC (-) SO NI

IMÁGENES DE INGRESO

TAC AP (26/12): Desarrollo de componente necrótico central de algunas de las localizaciones secundarias hepáticas conocidas, estables en tamaño. Distensión de asas de intestino delgado con cambio de calibre en excavación pelviana que podría traducir obstrucción intestinal mecánica de bajo grado sin signos de isquemia transmural de asas.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1.Shock Hipovolémico v/s Séptico

a.Foco abdominal

2.AKI KDIGO III

a.Hipokalemia Leve

3.Obstrucción intestinal bajo grado

4.Compromiso de conciencia tóxico-metabólico.

5.Antecedentes: Tumor neuroendocrino de pulmón con MTT hepáticas y óseas, en tratamiento con somatostatina + everolimus.

EVOLUCION POR PLANES DURANTE ESTADÍA

Hemodinámico: Paciente ingresa en shock hipovolémico por pérdidas digestivas, con buena respuesta a volumen. Evoluciona con sospecha de SLT y falla renal asociada por lo que se indica volemicización intensiva durante su estadía en UTIM. Luego de convulsión es intubada, con bajos requerimientos de NAD que se logra suspender tras suspensión de sedo analgesia (05/01). Desde entonces con hemodinamicamente estable, se mantiene con amlodipino.

Ventilatorio: Inicialmente sin conflicto ventilatorio. El 03/01 tras convulsión, se intuba. Se logra avanzar en weaning de forma lenta, alternando modos más controlados con CPAP. Se extuba 13/01, saliendo a VMNI con destete difícil, con conexión intermitente. Se titula oxigenoterapia a la baja logrando destete de oxígeno 22/01. Sin conflictos desde entonces.

Nefrológico/Medio Interno: Creatinina basal 0.68 (24/11/25). A su ingreso AKI KDIGO III obs pre-renal. Inicialmente responde a volemicización con crea hasta 3.1, evolucionando con alza hasta Crea 5.0/BUN 88 y oliguria, asociado a SOC con hemoglobinuria, hipocalcemia severa e hiperfosfemia severa interpretado como Lisis Tumoral/Necrosis de MTT, se maneja con volemicización profusa y alopurinol y calcio en bolo. Frente a no resolución de alteraciones metabólicas tras volemicización, se decide TRR de urgencias, primera sesión el 02/01/26. Función renal evoluciona favorablemente, con cese de necesidad de HD y retiro de CHD. Actualmente función renal sin alteraciones. Se suspende alopurinol. Se mantiene con hipokalemias leves e hipernatremias leves intermitentes, actualmente con papelillo K. Seguimiento seriado de parámetros.

Infectológico: Destacan 3 hits infecciosos.

1. A su ingreso con gastroenteritis aguda. En TAC AP de ingreso se pesquisa obstrucción intestinal de bajo grado. Se sospecha shock de etiología séptica y recibe Ceftriaxona/Metronidazol, que luego es suspendido debido a que se mantiene afebril sin presencia de foco clínico.

2. El 12/01 se detecta un aumento de la procalcitonina 38 (0.08 del 07/01), por lo que se pancultiva y se retira CYD. HC bacilos Gram (-), 16 horas, iniciándose Imipenem. Resultado de HC (+) para Enterobacteria Hafnia alvei, traslapándose a Ertapenem completando 7 días (14/01-21/01).

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 16:59

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 16:59:23

Página 3 de 5

3. Evolucionar 22/01 con peak febril sin compromiso hemodinámico. PCR estacionaria peri 60 inicialmente. Se decide pancultivo, destacando SO NI, Toxinas CD (-), PVR (-). UC (-) HC I Y II (P) SARS COV (-). Se difirió inicio de antibioterapia con control de PPII a la baja, afebril hasta la fecha. Sin mayor conflictos desde entonces

Neurológico: El 03/01 durante hemodiálisis presenta convulsión tónico-clónica que cede con LZIP, intubándose posteriormente. TC cerebral sin alteraciones. En EEG del 05/01 Anormal. Frecuente lentitud intermitente anterior bilateral. Evaluada por Neurología, impresiona compromiso de conciencia toxico-metabólico, sin nuevos eventos convulsivos. Se mantiene con Levetiracetam, disminuyéndose dosis 23/01 con plan de suspender 30/01.

Gastroenterológico: A su ingreso con gastroenteritis aguda. En TAC AP de ingreso se pesquisa obstrucción intestinal de bajo grado que se maneja con manejo médico con mejoría en imagen de control, actualmente resuelta.

Hematología: Destaca anemia N-N de larga data durante estadía, sin exteriorización de sangrado. Estudio con perfil hierro, Vit B12, Vit D y hemograma formal sin alteraciones.

Oncológico: Paciente con antecedente de tumor neuroendocrino de pulmón con MTT hepáticas y óseas, en tratamiento con Somatostatina + Everolimus. Imágenes sin progresión, pero, con SLT con indicación de terapia sistémica citotóxica. Se administró somatostatina 27/01 sin conflictos.

Rehabilitación:

- KNT: sentándose en sillón. Logra caminar con asistencia.
- FNA: Actualmente régimen licuado + fresubin. Lento.

Profilaxis: HBPM.

LABORATORIO

29/01: BUN 10 141/4/104

28/01: ELP 148/4.3/111 BILI T 0.3 CREA 0.4 BUN 13 LDH 331

27/01: HB 8.1 GB 9610 PLQ 612.000 ELP 148/3.1/109 CREA 0.4 BUN 10 PCR 37

ETIOLOGICOS:

- hierro 52 TIBC 167 % SAT 31 FERRITINA 999 B12 1081 VIT D 18 HB 8.2 GB 10600 PLQ 6120

ERITROCITOS: Anisocitosis ++, Poiquilocitosis +, Esferocitos +, Hipocromía +, Policromatofilia

+ ,Anisocromía + LEUCOCITOS Granulación tóxica +, Granulación tóxica degenerativa + PLAQUETAS aumentadas

IMAGENES:

TC TORAX 19/01: Moderado derrame pleural derecho y leve derrame pleural izquierdo estables en cuantía en comparación a estudio previo. Atelectasias pasivas parciales de ambos lóbulos inferiores. Nódulos centrolobulillares en ambos lóbulos inferiores sugerentes de bronquiolititis celular hallazgo que ya era visible en estudio p r e v i o. Resto del estudio sin cambios.

TC TORAX 04/01: Neumopatía multifocal de probable etiología inflamatoria infecciosa. Leve derrame pleural bilateral, mayor a derecha.

ECO RENAL: Leve nefromegalia asociado a signos de nefropatía médica bilateral.

TC ABD Y PELVIS 29/12: Menor grado de dilatación de las asas de intestino delgado en excavación pelviana con respecto estudio previo. Artefacto de movimiento y pulmones en espiración, lo que limita la evaluación. Áreas seudonodulares en el LII parcialmente caracterizable en este estudio dado artefacto de movimiento descrito, aparentemente sin cambios significativos, indeterminadas. Leve derrame pleural bilateral. Múltiples lesiones hepáticas secundarias bilobares sin cambios con respecto estudio reciente. Estabilidad en la extensión del compromiso óseo secundario en esqueleto axial y apendicular visible con respecto estudio reciente.

Microbiología:

25/12 HC I Y II (-) SO NI UC (-)

30/12 / 03/01: VHC Y VHB (-)

31/12 CLOSTRIDIUM A Y B (-)

04/01 PORTACION E VAN B (-) BLEE (-)

05/01 PANEL VIRAL (-) PCR COVID (-)

14/01: PANEL MOLECULAR PCR HEMOCULTIVO ENTEROBACTERIAS (+) HC I Y II Hafnia alvei (16.00 HRS) R

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 16:59

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 29-01-2026 16:59:23

Página 4 de 5

AMPISULBACTAM / CEFAZOLINA / CEFOTAXIMA / TAZONAM

15/01 SO GB 5-10 UC POLIMICROBIANO

16/01 PUNTA CETATER ST EPIDERMIDIS (SOLO S COTRI) Y HAEMOLYTICUS (MR)

17/01 TOXINAS A Y B (-) CARBAPENEMASA (-)

18/01 HC I Y II (-)

19/01 CULTIVO PUNTA CATETER (-)

20/01 SO GB 25-50 UC (-) CANDIDA (+)

21/01 PORTACION EN TEROCCO VAN B (-) CARBAPENEMASA (-)

22/01 SO GB 5-10 UC (-) HC I Y II (-)

23/01 PVR (-) SARS COVID (-) CLOSITRIDIUM A Y B (-)

OTROS

EEG (05/01): Sin actividad epileptiforme ni patrón de crisis. Conclusión: Anormal. Frecuente lentitud intermitente anterior bilateral. Disfunción lenta continua generalizada.

DIAGNOSTICOS ACTUALES

- Paciente crítico crónico
- Hipernatremia leve resuelta
- Hipokalemia leve resuelta
- Anemia moderada en seguimiento

Resueltos:

- Síndrome de Lisis Tumoral - resuelta
 - Obs. Necrosis de MTT hepáticas
- AKI KDIGO III Oligúrica (HD 02/01) - resuelta
 - Hiperfosfemia e hipocalcemia severa - resuelta
 - Hiperuricemia - resuelta
 - Acidosis metabólica severa - resuelta
- Bacteriemia por Enterobacteria Hafnia alvei - tratada
- Shock hipovolémico - resuelto
- Gastroenteritis aguda - resuelta
- Obstrucción intestinal bajo grado - resuelta.
- Convulsión tónico / clónica etiología tóxico-metabólico - resuelto
- IOT 03/01 - 13/01
- Tumor neuroendocrino de pulmón con MTT hepáticas y óseas

Diagnóstico de Egreso

CONVULSIONES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente se ha mantenido normocárdica, normotensa, afebril. Sin apremio respiratorio o requerimiento de oxígeno. Sin dolor. Sin náuseas o vómitos. Último peak febril 37.8 grados 22/01 10.00 AM. Diuresis (+) Deposiciones (+) sin elementos patológicos.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Regimen Licuado + líquido espeso pausado y asistido. Medicamentos molidos con agua espesada.

Kinesioterapia motora + respiratoria / Terapeuta ocupacional / Fonoaudiología en domicilio de forma particular.

Br ipratropio 2 puff c/12 hrs x AEC

Papelillos KCL 2.5 gr al día VO

Amlodipino 5 mg al día, por VO

Levetiracetam 250 mg cada 12 horas, por VO hasta el día viernes 30/01/25 luego suspender.

Ácido Fólico 5 mg al día, por VO

Fecha Epicrisis : 29/01/2026 16:59

Página 4 de 5

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 29-01-2026 16:59:23

Página 5 de 5

SOS

Paracetamol 1 g VO en caso de dolor o fiebre (máximo casa 8 horas)

Control de exámenes cada 48 horas para seguimiento de medio interno (ELP) y evaluar suspensión de KCL.

Indicaciones

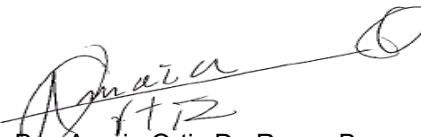
Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Bec. Amaia Ortiz De Rozas Bernar
Becado/Residente


Sebastián Oksenberg Sharim
Médico Tratante (Staff)